SDD 35 Sujet n°1

Spécialité : douleur / médecine générale

Date : 08/10/2024
Auteur : Clémence DIZABO (DES médecine générale - EDN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Education/prévention
Item(s) en lien avec la station	135 Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses
Situation(s) de départ en lien avec la station	SSD 35 Douleur chronique
Matériel nécessaire à la station	aucun
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de médecine générale en ville.
Vous recevez Madame D, âgé de 40 ans, professeure des écoles, au cabinet. Celle-ci présente des douleurs chroniques. Vous souhaitez faire un point sur celles-ci.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser un interrogatoire sur la douleur chronique de la patiente
- Proposer d'éventuels conseils à la patiente pour la gestion de sa douleur

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'ordonnance
- Introduire de nouveaux traitements

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche l'ancienneté ET la localisation de la douleur	1 pt	☐
2.	Recherche un facteur déclenchant à la douleur (évènement de vie concomitant)	1 pt	☐
3.	Recherche le type de douleur - Neuropathique : brûlures, fourmillements, picotements, décharges électriques, engourdissements, sensation de froid douloureux, démangeaisons, allodynie, hypoesthésie (au moins 5/9)	1pt	☐
4.	Recherche l'évolution de la douleur - Douleur constante (présence de fond douloureux) ou intermittente (moment de répit) - Douleurs diurnes et/ou nocturnes	1 pt	☐
5.	Recherche les antalgiques essayés ET leur efficacité	1pt	☐
6.	Recherche les autres moyens mis en place pour lutter contre la douleur (kiné, TENS, ostéopathie, hypnose, acupuncture…) OU la pratique d'une activité physique	1 pt	☐
7.	Recherche un retentissement psychologique OU un éventuel suivi psychologique/psychiatrique	1 pt	☐
8.	Se renseigne sur la situation professionnelle (conflit, AT) OU sur le retentissement au travail	1 pt	☐
9.	Propose un sevrage **progressif** des benzodiazépines	1 pt	☐
10.	Propose un sevrage des opiacés avec utilisation ponctuel en traitement de crise	1 pt	☐
11.	Conseille de pratiquer une activité physique	1 pt	☐

12.	Conseille la reprise de la kinésithérapie	1 pt	☐
13.	Propose une consultation douleur OU suivi dans un centre spécialisé dans la douleur	1 pt	☐
14.	Propose un suivi psychologique	1 pt	☐

Communications et attitudes

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TOTAL	17 points

Éléments de rétroaction :

Je voulais aborder dans cette station une partie assez floue du medline Douleur et Soins palliatifs mais finalement très bien développée sur le site de la HAS (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/grille_de_premiere_evaluation_dun_patient_douloureux_chronique_en_soins_primaires.pdf) et bien au programme des ECOS ("Réaliser un interrogatoire du patient selon les recommandations de la HAS pour la douleur chronique").
L'exemple type du patient douloureux chronique est le patient fibromyalgique. Il est important de rechercher un événement de vie concomitant à l'apparition de la douleur (traumatisme fréquent…).
On retrouve 3 types de douleurs : nociceptives (présence d'une lésion), neuropathique et nociplastique (pour faire simple, c'est un dysfonctionnement au niveau du centre de la douleur, un phénomène de sensibilisation centrale qui engendre des douleurs sans lésions ; celle-ci peut être recherchée grâce à l'inventaire de sensibilisation centrale).
Penser à l'évolution de la douleur ++ et à ses moyens pour la combattre.
Au niveau des traitements :

- *Ne pas oublier d'évaluer l'efficacité de chaque mesure. Un traitement inefficace n'a pas d'intérêt !!*
- *Attention au mésusage. Les opiacés ne sont pas des traitements de fond dans la douleur chronique mais seulement des traitements de crises. Ils peuvent même entraîner une hyperalgésie.*
- *On arrête jamais la morphine ou les benzodiazépines brutalement. Les benzo c'est max 4 à 12 semaines (selon son objectif).*
- *Je n'ai pas voulu aller trop loin mais s'il avait fallu instaurer un traitement on aurait pu mettre un antidépresseur (tricyclique ou IRSNa).*
- *Sinon, l'activité physique c'est le meilleur traitement de la douleur* 🙂

Pour finir, il faut toujours évaluer le retentissement, quand on a mal, on ne va pas bien et quand on ne va pas bien, on a mal. Rechercher d'éventuel(s) arrêt(s) de travail, dépression/anxiété (score HAD par exemple), conflit familial (les douloureux chroniques sont souvent mal compris, surtout devant un handicap invisible)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Madame D vient en consultation dans le cadre du suivi de ses douleurs chroniques

Plan de la station ECOS :

Patiente sur une chaise en face du médecin

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour Docteur, je viens pour faire le rpoint sur mes douleurs

Identité du patient :

Femme, Lisa D, 40 ans, 1 m 60 60 kg

Mode de vie :

Professeure des école
Marche 1h le samedi
Mariée
Pas d'enfant
Pas d'intoxication alcoolo-tabagique

Comportement global :

Patiente fatiguée, épuisée du fait de ses douleurs

Antécédents personnels :

Fibromyalgie (diagnostic il y a 10 ans)
1 grossesse il y a 17 ans

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Pour la W. H. Ydouleur :

- Morphine LP 10 mg matin et soir
- Morphine LI 2 mg si besoin (en moyenne 2 fois par jour)
- Paracétamol 1 g toutes les 6 heures

Zopiclone pour dormir (depuis 10 ans)

Symptômes positifs :

Si l'étudiant demande l'ancienneté des douleurs : "ça fait depuis 12 ans que j'ai mal"

Si l'étudiant demande la localisations des douleurs : "partout dans mon corps, surtout au niveau des épaules et des jambes"

Si l'étudiant demande l'intensité de la doulueur : "7/10"

Si l'étudiant demande l'évolution de la douleur :

- Fond douloureux permanent (4/10)
- Réveils nocturnes
- Pics dans la journée
- Facteurs soulageant : repos, changement de position
- Facteurs aggravants : ne sait pas

Si l'étudiant demande un facteur déclenchant : mort de son fils à l'âge de 5 ans (accident de voiture)

Si l'étudiant recherche le type de douleurs : comme des décharges électriques, pas de trajet précis, parfois des brûlures

Si l'étudiant recherche des signes associés : fatigue +++, troubles digestifs avec alternance diarrhée/constipation, difficultés de concentration

Si l'étudiant recherche l'efficacité des traitements :

- La morphine me soulageait au début mais maintenant j'ai l'impression d'avoir encore plus mal
- Paracétamol soulage légèrement

Si l'étudiant recherche des moyens de lutte contre la douleur (autres que médicamenteux) :

- Kinésithérapie : "j'ai arrêté il y a 7 ans" "ça faisait mal"
- "J'ai un appareil de TENS que j'utililise seulement le week-end par manque de temps mais ça me soulage bien"

Si l'étu diant recherche un retentissement :

- Psychologique : tristesse et anxiété, difficultés à dormir. Jamais eu de suivi psychologique/psychiatrique “je me débrouille toute seule mais je sens que ça commence à faire beaucoup”
- Sur le travail : obligée d’alterner la position assise/debout fréquemment pour soulager ses douleurs
- Social : restriction des sorties avec ses ami(e)s

H’h’´´